1a à un titre élevé. Le diagnostic de PPT est posé. Un traitement par immunoglobulines IV à fortes doses 1 g/kg/j pendant 2 jours est institué permettant un retour à un taux de plaquettes normal à 157 g/l à J + 18.
Discussion Le PPT est une complication rare de la transfusion, mais sévère pouvant mettre en jeu le pronostic vital par la thrombopénie majeure associée. En France, depuis 2012, 1 seul cas de PPT a été déclaré au pôle hémovigilance de l'ANSM. Le PPT est causé par une réponse anamnestique suite à une allo-immunisation contre les antigènes plaquettaires. Les anticorps apparaissent après une grossesse ou une transfusion et sont dirigés le plus fréquemment contre les antigènes HPA-1a. Lors d'un PPT, les patients détruisent les plaquettes transfusées, mais également leurs propres plaquettes par un mécanisme non encore totalement élucidé. Le traitement repose sur des immunoglobulines humaines polyvalentes intraveineuses à forte dose.
Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2021.08.105

Session orale - OR5- International

OR5-1

Emergence du VIH chez les donneurs de sang en Tunisie

Taicir Rekik, Hela Menif, Abir Hachicha, Jalel Gargouri, Nour Louati, Ikram Ben Amor*
CRTS Sfax, LR19SP05, Université de Sfax, Sfax, Tunisie
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : ikrambenamor.hemato@gmail.com (I. Ben Amor)

Notre but est de rapporter l'évolution des indicateurs du VIH chez les donneurs de sang (DDS).
Il s'agit d'une étude exhaustive qui a concerné les DDS de compensation et volontaires prélevés aux cabines mobile et fixe sur 11 années (Janvier 2010-Décembre 2020). Le dépistage combiné des antigènes et Anticorps anti-VIH a été fait par ELISA et la confirmation des positifs par Western blot. Les prévalences et les séroconversions selon la tranche d'âge, le sexe et le type de don ont été éditées par le logiciel Hématos de MedInfo. L'incidence et le risque résiduel (RR) ont été calculés selon le modèle mathématique de Shreiber.
La prévalence globale du VIH a été de 0,114‰ (38/323802 DDS). Elle a été significativement plus élevée au-delà de 25 ans (0,017‰ chez les 18-25 ans contre 0,134‰ au-delà ; $p = 0,01$ dont la majorité entre 25 et 40 ans]. Ni le sexe ni le type de don n'avaient significativement influencé cette prévalence [0,115 des hommes et 0,106‰ des femmes ($p = 0,87$) et 0,120‰ et 0,059‰ chez les DDS de compensation et volontaires ($p = 0,31$)]. La prévalence a significativement augmenté au fil des années de 0,068‰ en 2010 à 0,314‰ en 2020 ($p = 0,03$). Six séroconversions ont eu lieu en 2019-2020, soit une incidence de 6,32/100 000 et un RR de 0,38/100 000 poches-année. Ce pic récent au VIH chez les DDS, reflétant celui dans la population générale, est concomitant à la régression des compagnes de prévention anti-VIH, à une libération sexuelle chez les jeunes mais aussi les aléas d'un système transfusionnel à majorité de dons de compensation.
Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2021.08.106

OR5-2

Evaluation des pratiques transfusionnelles : étude multicentrique

Nouha Ben Amara, Sonia Mahjoub*, Rania Bel Hadj, Aya Chakroun, Neila Ben Romdhane
Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : sonia.mahjoubghozzi690@gmail.com (S. Mahjoub)

Introduction La transfusion sanguine est une activité complexe non dénuée de risques. La connaissance des pratiques transfusionnelles sécuritaires par le personnel soignant (infirmiers) est primordiale. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'impact d'utilisation des fiches techniques (FT) de conduites pratiques en transfusion sanguine sur le plan théorique et pratique.
Méthodes Il s'agit d'une étude prospective évaluative et interventionnelle réalisée entre février et mai 2021. L'étude a été faite dans trois établissements de santé publique. Une première évaluation des connaissances théorique par un questionnaire et pratique par une grille d'observation a été menée. L'évaluation a été répétée après la remise de quatre FT. Deux critères de jugement ont été utilisés : le taux de bonnes réponses (TBR) et les changements des comportements avant et après formation.
Résultat Trente-cinq réponses ont pu être analysées (taux de réponse complète = 73 %). TBR sur les connaissances globales a passé de 53 % à 95 % après FT. Une amélioration significative des connaissances ($p = 10\text{-}3$), des pratiques ($p = 0.012$) et des aptitudes ($p = 0.043$) après FT a été noté. L'analyse montre que les FT ont eu un impact essentiellement sur la pratique du test ultime ($p = 0.01$) et la surveillance et le contrôle ($p = 0.012$). Néanmoins les conduites face aux incidents transfusionnels restent inadaptées après FT.
Conclusion Cette étude souligne l'impact des FT comme aide-mémoire en matière de sécurité transfusionnelle. Toutefois, une optimisation des FT et une généralisation de leurs utilisations sont requises.
Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2021.08.107

OR5-3

Place de la sélection médicale au don de sang au CRTS Analamanga -Madagascar

Elodie Emile Batavisoaniatsy[1,*], Fenosoa Anita Mireille Tsatoromila[2], Bronislaw Tchesterico Dodoson[2], Ianja Razanadrakoto[1], Aimée Olivat Rakoto Alson[3], Andry Rasamindrakotroka[5], Zely Arivelo Randriamanantany[4]
[1] *Centre Régional de Transfusion Sanguine Vakinankaratra, Antsirabe, Madagascar*
[2] *Centre Régional de Transfusion Sanguine Analamanga, Antananarivo, Madagascar*
[3] *Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar*
[4] *Direction de la Transfusion Sanguine, Antananarivo, Madagascar*
[5] *Faculté de Médecine - Université d'Antananarivo, Antananarivo, Madagascar*
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : elodie.kwely@gmail.com (E.E. Batavisoaniatsy)

Introduction Dans la prévention des infections transmissibles par la transfusion, l'objectif de l'étude est d'évaluer l'efficacité de la sélection médicale pré-don chez les candidats au don de sang du CRTS Analamanga.
Méthode Une étude prospective observationnelle a été effectuée au premier trimestre de 2019. Il s'agit d'une comparaison des pré-

valences de 4 agents infectieux transmissibles par la transfusion, chez les donneurs autorisés et les candidats exclus. Un test ELISA a été performé pour l'Ag HBs et les anticorps anti-VHC. Les anticorps anti-VIH étaient screenés par test immunochromatogra- phique. Les tests RPR et TPHA ont été utilisés pour la syphilis. L'analyse statistique a été faite sur Microsoft Excel et Epi Info 7.0.
Résultats La sélection médicale a permis d'autoriser 3638/4228 donneurs soit 86,01 %. L'âge moyen est plus élevé chez les donneurs autorisés avec prédominance masculine dans les 2 groupes. Tous les candidats exclus ont été vus en site fixe dont 94,29 % étaient des donneurs familiaux de remplacement. Les comportements sexuels à risque et les dermatoses ont été les principaux motifs d'exclusion. La prévalence était plus élevée chez les candidats exclus pour l'Ag HBs (32,86 % contre 2,38 %) et les anticorps anti-VHC (10 % contre 0,34 %). Aucune infection par le VIH n'a été retrouvée chez les candidats exclus.
Conclusion Cette étude a permis de montrer l'efficacité des procédures actuelles de sélection au don vis-à-vis du VHB et du VHC. Le faible taux de donneurs bénévoles réguliers demande une sélection médicale plus stricte qui est à balancer avec le risque potentiel de pénurie de donneurs (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Caractéristiques des deux groupes de candidats au don de sang.

	Donneurs autorisés n =3489	Donneurs exclus n =70	Comparaison (p)
Age moyen (ans)	34.87 ±11.33	29.02 ± 8.90	0.009
Minimum	18	19	
Maximum	72	56	
Sex ratio (H/F)	2.5	2.7	0.358
Site de collecte (%)			0.001
Site mobile	8.28	0.00	
Site fixe	91.72	100	
Type de dons (%)			0.003
Donneurs bénévoles réguliers	13.01	1.42	
Nouveaux donneurs bénévoles	8.89	4.29	
Donneurs familiaux	78.10	94.29	

Tableau 2 Comparaison de la prévalence des 4 agents infectieux évalués.

Infections	Donneurs autorisés n =3489	Donneurs exclus n =70	Comparaison (p)
Positivité globale (%)	**3.26 (114)**	**37.14 (26)**	0.0001
VHB positif	2.38 (83)	28.57 (2)	0.0001
VHC positif	0.34 (12)	7.14 (5)	0.0001
VIH positif	0.34 (12)	-	0.39
Syphilis positif	0.20 (7)	1.43 (1)	0.07

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2021.08.108

OR5-4

Identification des variants D partiels au centre pasteur du Cameroun

Jeanne Manga Messina*, Leopold Mbous Nguimbous, Francoise Ngo Sack, Annie Epote, Suzanne Belinga
Centre Pasteur du Cameroun, Yaoundé, Cameroun
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : mangajeanne@yahoo.fr (J.M. Messina)

Les méthodes sérologiques de groupage sanguin Rhésus D présentent très souvent des résultats discordants du fait de la présence des variants mettant les biologistes dans une impasse décisionnelle lors du rendu de ces résultats. Dans le but d'identifier les variants D partiels, une étude transversale a été menée au laboratoire d'Hématologie du Centre Pasteur du Cameroun d'avril 2016 à juin 2017. 5 mL de sang sous EDTA étaient prélevés chez tous les patients venus pour le groupage sanguin ABO/D. La recherche de l'antigène D était faite par 3 antiséra monoclonaux de Biorad l'anti D IgG (MS-26)/IgM (TH-28) sur plaque et les antiséra anti DVI- [LHM59/20(LDM3)+175-2] et anti DVI+[ESD-1M+175-2] sur gel-filtration. Les échantillons présentant des discordances de résultats étaient analysés par un panel Extended partial Rh D typing de 12 antisera anti D (LHM76/58 ; LHM76/59 ; LHM174/102 ; LHM50/2B ; LHM169/81 ; ESD1 ; LHM76/55 ; LHM77/64 ; LHM70/45 ; LHM59/19 ; LHM169/80 ; LHM57/17) pour l'identification des variants D partiels. Des 3492 patients reçus, seuls 55(1,58 %) ont présenté des discordances de résultats avec un sex-ratio 0,195 en faveur des femmes et une classe modale de 20 à 29 ans. La caractérisation des variants a révélé 7,27 % de D faible et 87,27 % de D partiels dont 36,36 % DFR, 32,73 % DV, 14,55 % DIII, 1,82 % DAR-E, 1,82 %DHK/DAU-4. L'utilisation des antiséra monoclonaux de lignées cellulaires différentes est indispensable pour la détection des variants D. L'identification de ces variants par des panels plus larges d'antiséra est nécessaire et devient de plus en plus inévitable en routine par les techniques moléculaires.
Mots clés Discordances ; Variants D partiels
Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2021.08.109

OR5-5

Motivation au don de sang, Mali

Minkoro Fomba[1,*], Ibrahima Moulaye Diarra[1], Mounirou Baby[2], Amadou B. Diarra[1]
[1] *Centre National de Transfusion Sanguine, Bamako, Mali*
[2] *Centre de lutte contre la drépanocytose, Bamako, Mali*
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : atou59@yahoo.fr (M. Fomba)

Introduction La problématique du don de sang dans les pays en voie de développement se pose avec acuité à cause d'un très faible nombre de donneurs de sang. Au Mali, de nombreuses personnes font le lien entre le don de sang et le dépistage du VIH/SIDA. En outre des considérations socioculturelles liées au sang ne favorisent pas le don de sang. Dans cet article nous étudions les connaissances, attitudes et pratiques des donneurs au don de sang à Bamako, afin de cerner tous les contours de cette problématique sociologique.
Matériels et méthodes Il s'agissait d'une étude transversale descriptive menée au CNTS et dans les quartiers de Bamako durant toute l'année 2017. Un questionnaire individuel a été administré auprès de 1000 donneurs et des focus group ont été réalisés auprès de 200 donneurs. L'échantillonnage a été exhaustif et consécutif. Ainsi, toutes les personnes qui se sont présentées durant la période de l'étude sur les sites de cabine fixe ou mobile ont été interrogées.
Résultats Le sexe masculin représentait 86,60 % des 1000 donneurs questionnés. La tranche d'âge 25 à 34 ans représentait près d'un donneur sur deux (42,10 %). Les professions libérales étaient la principale catégorie socioprofessionnelle (43 %) chez les donneurs volontaires. Sur les 1000 donneurs, 71 % étaient des donneurs familiaux ou de compensation, les autres 29 % des donneurs volontaires.
Conclusion Afin de recruter plus de donneurs volontaires, nous recommandons entre autres d'intensifier la collecte mobile auprès de la population, d'informer clairement la population sur l'utilité du don de sang et d'impliquer les leaders (politiques et religieux) dans la sensibilisation au don de sang.
Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2021.08.110